Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная
больница № 2»
194354 С-Петербург, Учебный пер., д.5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2»
ОГРН 1037804000630
Адрес 194354, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д.5

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ № МК 114018-26-С
29.10.2026 13:29 ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

Наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), ОГРН (ОГРНИП): Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская многопрофильная больница №2", 1037804000630
Наименование отделения (структурного подразделения):
с 26.10.2026 17:32 по 26.10.2026 18:47 - Неврологическое отделение №1
с 26.10.2026 18:47 по 27.10.2026 18:36 - Неврологическое №1 (ПИТ)
с 27.10.2026 18:36 по 29.10.2026 13:29 - Неврологическое отделение №1
Номер медицинской карты: 114018-26-С

Сведения о пациенте:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Кузьмин Андрей Иванович
Дата рождения: 12.05.1963 Пол: М
Регистрация по месту жительства: Санкт-Петербург г., Выборгский р-н, Луначарского пр-кт., д.1, корп.2, кв.122
Регистрация по месту пребывания: Санкт-Петербург г., Выборгский р-н, Луначарского пр-кт., д.1, корп.2, кв.122

Поступил: в стационар - 1
Период нахождения в стационаре: 26 октября 2026 г. 17 час. 32 мин. по 29 октября 2026 г. 13 час. 29 мин.
Количество дней нахождения в медицинской организации: 3 д
Исход госпитализации: выписан из стационара
Результат госпитализации: улучшение
Форма оказания медицинской помощи: экстренная - 2
Дополнительные сведения о пациенте и госпитализации:
Общее состояние при выписке: удовлетворительное
Полис ОМС: 7854630837001722
Страховая компания: АДМИНИСТРАТИВНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КАПИТАЛ МС" - ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата выдачи полиса: 11.04.2017
Направлен учреждением: Больница №2 (Другие ЛПУ)

Заключительный клинический диагноз:

Основное заболевание: D33.1 Объемное образование IV желудочка с синдромом гидроцефалии и эпизодами позиционной рвоты, симптомом Брукса
Состояние после хирургического и радиохирургического лечения рецидивирующей шванномы VIII ч.н. слева 20213, 2014, 2024г., лечение гамма-ножом в 2024 г.
Сопутствующие заболевания: K91.5 Постхолецистэктомический синдром (ЖКБ, холецистэктомия 2009г): дисфункция сфинктера Одди.
K29.6 Хронический гастрит, ассоциированный с дуодено-гастральным рефлюксом.
H35.0 OD: Гипертоническая ангиопатия сетчатки. Артифакия
OS: Васкуляризованное бельмо роговицы. Частичный птоз верхнего века. Спастический выворот нижнего века. Лагофтальм. Начальная сенильная катаракта
K86.1 Хронический панкреатит.
I 11.9 Гипертоническая болезнь. Атеросклероз аорты и ее ветвей.

Состояние при поступлении
Жалобы

активно не предъявляет

Анамнез заболевания
Со слов: болен с 2010 г., когда появились нарушения слуха на левое ухо. Обращался к оториноларингологу и неврологу, диагностировали шейный остеохондроз. Через три года появилась шаткость походки. При повторном осмотре неврологом заподозрена опухоль ЗЧЯ, подтвержденная на МРТ головного мозга. В РНХИ им Поленова произведена операция: удаление шванномы слухового нерва слева. В п/о периоде отмечает отсутствие слуха на левое ухо, асимметрия лица слева, не закрывался левый глаз, сухость глаза, появилось бельмо слева, шаткость уменьшилась. Последующие 4 года чувствовал себя стабильно. В 2017 г. при контроль МРТ выявлен рецидив опухоли, проведена радиотерапия гамма-ножом. До 2023 г. состояние стабильное, однако усилилась шаткость, выявлен рецидив опухоли, повторное хирургическое вмешательства в РНХИ им. Поленова. В течение последних 1,5 месяцев отмечает появление внезапной рвоты в начале 1 раз в недели, за последние три недели — ежедневно по несколько раз; тошнота и рвота, приносящие облегчение. Три недели назад усилилась шаткость. По поводу рвоты госпитализирован в отделение гастроэнтерологии ГМПБ № 2 2 недели назад. Диагностирован рефлюкс-эзофагит. Однако причины рвоты остаются неясными. В связи с выявлением на МРТ головного мозга от 26.10.2026 г. изменения в шейном отделе СМ, подозрительных на миелоишемию был переведен в 1 НО ГМПБ № 2..
Анамнез заболевания пациента с ОНМК
Невозможно оценить: нет.
Анамнез жизни
Хронические заболевания: Хронический панкреатит, фаза обострения
Постхолецистэктомический синдром (ЖКБ, холецистэктомия 2009г): дисфункция сфинктера Одди.
Варикозная болезнь вен нижних конечностей
Хронический комбинированный геморрой.
Хронический гастрит, ассоциированный с дуодено-гастральным рефлюксом. ГПОД. ГЭРБ: неэрозивный рефлюкс-эзофагит
ЦВБ. Церебральный атеросклероз. ХНМК в ВББ. Состояние после оперативного лечения вестибулярной шванномы слева (2013, 2024гг) с периферическим прозопарезом слева и формированием тяжелых контрактур.
Гипертоническая ангиопатия сетчатки. Артифакия. Васкуляризованное бельмо роговицы. Частичный птоз верхнего века. Спастический выворот нижнего века. Начальная сенильная катаракта. Туберкулез: нет. ВИЧ-инфекция: нет. Вирусные гепатиты: нет. Перенесенные травмы: перелом правой ключицы 2023г. . Перенесенные операции: 2013г. Рецидив 2017г - гамманож. Рецидив 2024г. в детском возрасте оперирован по поводу фимоза, мастопатии справа, холецистэктомия по поводу ЖКБ; хронический гастрит, рефлюкс-эзофагит, хронические запоры; катаракта справа, замена хрусталика. Постоянно принимает: отрицает. Реакция на: нет. В настоящее время: работающий. Место работы, должность: ГБУЗ СПб ГМПБ №2, плотник.
Объективный статус.
Рост/длина тела: 184 см; Масса тела: 94 кг; Температура: 36,6 °С; ИМТ: 27,8 кг/кв.м; Площадь поверхности тела: 2,19 кв.м;

Общие сведения
Общее состояние: средней тяжести. Сознание: ясное. Питание: удовлетворительное.
Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов
Развитие ПЖК: умеренно. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен.
Состояние органов дыхания
Тип дыхания: самостоятельное. ЧДД: 17 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. Описание дыхания: . SPO2: 98 %; Характер дыхания: везикулярное (нормальное). Хрипы: нет.
Состояние сердечно-сосудистой системы
Систолическое давление: 120 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 80 мм.рт.ст.; ЧСС: 75 /мин; Пульс: 75 /мин; Дефицит пульса: 0 1/мин; Наполнение пульса: умеренного наполнения. Напряжение пульса: умеренного напряжения.
Состояние органов желудочно-кишечного тракта
Цвет языка: розового цвета. Участие живота в акте дыхания: участвует. Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные.
Состояние мочеполовой системы
Мочеиспускание с начала заболевания: было. Мочеиспускание: не нарушено. Моча: без изменений. Цвет мочи: желтый (обычный).

Шкалы:
ШКГ: 15 баллов; Рэнкин: 3; Индекс Бартела: 100/115 (полная независимость); NIHSS: 4;
Оценка по шкалам и её динамика
NIHSS: 27.10.2026 - 4
Индекс Бартела: 27.10.2026 - 100
Рэнкин: 27.10.2026 - 3
Шкала комы Глазго: 27.10.2026 - 15
Неврологический статус.
Уровень сознания: ясное. Ориентация: в пространстве, времени и собственной личности сохранена. Игнорирование: не выявлено. Дизартрия: дизартрия легкой степени. Речь: не изменена. Величина и симметрия зрачков: D=S. Менингеальный синдром: не выявлен. Движение глазных яблок: не изменено. Реакция зрачков на свет: в норме. Поля зрения: не изменены. Диплопия: нет. Мимическая мускулатура: парез мимической мускулатуры по периферическому типу слева . Слух: снижен слева. Глотание: не изменено. Чувствительная сфера: не изменена. Мышечная сила: не изменена. Патологические знаки: + с-м Бабинского с 2-х сторон . Походка: не изменена . mRs: 2.

Проведенные обследования, лечение, медицинская реабилитация

Осмотры врачей-специалистов, консилиумы врачей, врачебные комиссии:

Консультация специалиста

Врач - офтальмолог: 27.10.2026 09:13:08
МЕЦАТУНЯНЦ
М. Р. Заключение: На момент осмотра острой глазной патологии не выявлено OU. Данных за застой ДЗН не выявлено OD. Достоверно оценить ДЗН не представляется возможным OS.
Врач по лечебной физкультуре: 27.10.2026 10:08:00
АНИСИМОВА
Л. Н. Заключение: Самостоятельно перемещается в постели; присаживается; сидит, удерживая равновесие. Без посторонней помощи встает, стоит; ходит по коридору. В процессе ходьбы , при повороте головы вправо, резко нарушается равновесие- до падения. В позе Ромберга не устойчив. Себя обслуживает : умывается, бреется, причесывается. Прием пищи осуществляет сидя за прикроватным столом.Переодевается. Элементы персональной гигиены выполняет полностью. Умеренное нарушение процессов жизнедеятельности. Индекс мобильности Ривермид-7 баллов..
Другое: 27.10.2026 10:30:00
СТАСЮЧЕНОК
Н. В. Заключение: На момент обследования нарушений в когнитивной сфере не выявлено. В целенаправленной нейропсихологической коррекции не нуждается. .
Врач - нейрохирург: 28.10.2026 15:00:00
Диагноз:
Клинический Основной Вестибулярная шваннома слева. Состояние после хирургического и радиохирургического лечения 20214, 2017, 2024г.
Очаг сосудистой миелопатии в верхне-шейном отделе спинного мозга. (D33.1)
Заключение: Ургентное нейрохирургическое лечение в настоящий момент не показано..
Рекомендации: МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением.
Плановая консультация нейрохирурга по месту первичной операции (РНХИ им. проф. А.Л. Поленова).

Консилиумы

Дата проведения: 28.10.2026 12:00.
Состав консилиума:
Врач - невролог: АШИРОВА ВИКТОРИЯ ГЕРМАНОВНА.
Название осмотра: Консилиум. :: Совместный осмотр проф. каф.неврологии Шулешовой Н.В, леч. вр. Ашировой В.Г., кл.орд Пьяных В.К, кл. орд. Исмоилов Ф.А.
Дата проведения: 29.10.2026 10:06.
Состав консилиума:
Врач - невролог: АШИРОВА ВИКТОРИЯ ГЕРМАНОВНА.
Название осмотра: Консилиум. :: Дополнение к анамнезу.
Результаты медицинского обследования:

Результаты лабораторных исследований

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови. 27.10.2026 10:41

Название теста	*Результат*	*Ед. изм.*	*Референсные значения*
Холестерин липопротеинов высокой плотности	0,92	ммоль/л	1,04 - 2,1

(альфа-холестерин) [моль/объем] в сыворотке или плазме			

Исследование уровня триглицеридов в крови. 27.10.2026 10:41

Триглицериды [моль/объем] в сыворотке или плазме	0,72	ммоль/л	0 - 1,7

Исследование уровня холестерина в крови. 27.10.2026 10:41

Холестерин [моль/объем] в сыворотке или плазме	3,66	ммоль/л	0 - 5,18

Исследование уровня липопротеинов в крови. 27.10.2026 10:41

Коэффициент атерогенности (ХС общий/ХС-ЛПВП) [Молярное отношение] в сыворотке или плазме	3,03		0 - 3
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) [моль/объем] в сыворотке или плазме крови методом прямого измерения	2,46	ммоль/л	0,8 - 4,1

Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) в сыворотке или плазме. 27.10.2026 10:41

Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) [моль/объем] в сыворотке или плазме	0,33	ммоль/л	0 - 0,78

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование. 27.10.2026 11:47

Поверхностный антиген Hepatitis B virus (HBs-Ag) [наличие] в сыворотке или плазме	Отрицательный		Отрицательный

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови. 27.10.2026 11:47

Антитела [наличие] к Hepatitis C virus в сыворотке или плазме	Отрицательный		Отрицательный

Применение лекарственных препаратов (включая химиотерапию, вакцинацию), медицинских изделий, лечебного питания:

Диеты

Диета: ОВД;

Состояние при выписке, трудоспособность, листок нетрудоспособности:

Объективный статус.

Общие сведения

Общее состояние: удовлетворительное. Сознание: ясное. Конституция: нормостенический. Питание: удовлетворительное.

Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов

Цвет кожных покровов: обычной окраски. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен. Цианоз: отсутствует. Наличие отеков: отсутствуют. Дополнительные сведения: t тела 36.6 гр С.

Состояние органов дыхания

Тип дыхания: самостоятельное. ЧДД: 17 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. Описание дыхания: . Участие грудной клетки в дыхании: равномерное. SPO2: 96 %; Характер дыхания: жесткое.

Состояние сердечно-сосудистой системы

Систолическое давление: 130 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 80 мм.рт.ст.; ЧСС: 72 /мин; Характеристика ритма: синусовый.

Состояние органов желудочно-кишечного тракта

Цвет языка: розового цвета. Симметричность живота: симметричный. Форма живота: округлая. Вздутие: нет. Участие живота в акте дыхания: участвует. Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные.

Состояние мочеполовой системы

Мочеиспускание: не нарушено. Моча: без изменений. Цвет мочи: желтый (обычный).

Состояние органов зрения

Зрачки: нормальные. Анизокория: нет. Симметрия зрачков: симметричны. Изменения зрачков: D= S. Менингеальный синдром: нет. Склеры: обычной окраски.

Местный, локальный статус.

Локальный статус: Уровень сознания: ясное; Дизартрия: дизартрия легкой степени (за счет

периферического пареза мимической мускулатуры слева); Величина и симметрия зрачков: D=S; Менингеальный синдром: не выявлен; Движение глазных яблок: не изменено; Реакция зрачков на свет: в норме; Поля зрения: не изменены; Диплопия: нет; Мимическая мускулатура: парез мимической мускулатуры по периферическому типу слева ; Слух: снижен слева; Глотание: не изменено; Чувствительная сфера: не изменена; Мышечная сила: не изменена; Патологические знаки: + с-м Бабинского с 2-х сторон ; Походка: не изменена ; mRs: 2.

Трудоспособность: Трудоспособность снижена. Листок нетрудоспособности выдан.
Номер л/н: .
Выдан с: 26.10.2026. По : 30.10.2026. Явка в поликлинику: 30.10.2026.

Рекомендации:
Также имеется подозрение на глиомматоз шейного отдела спинного мозга, ствола мозга.
Дифф.диагноз с паразитарной кистой

1. Явка в поликлинику 30.10.2026 г
2. Консультация врача-нейрохирурга в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова для решения вопроса об оперативном лечении
3. МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением амбулаторно
4. Диакарб 250 мг утром и вечером под наблюдение невролога, нейрохирурга
5. Панангин по 1 таблетка 3 раза в день
6. Лозартан (Лориста) 25 мг утром - длительно

Ежегодное прохождение диспансеризации (профилактического медицинского осмотра).

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, специальность, подпись:
ФИО врача: Аширова Виктория Германовна / Врач - невролог
ФИО Заведующего отделением: Чернявский Иван Валерьевич / Заведующий отделением неврологии - врач - невролог

29 октября 2026 г. 13 час. 29 мин.

Врач-невролог /_____ / АШИРОВА ВИКТОРИЯ ГЕРМАНОВНА

Заведующий отделением врач-невролог /_____ / ЧЕРНЯВСКИЙ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ